CURSO DE FISIOTERAPIA • 2º TERMO

BASES E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO I

FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA

Anamnese • Sinais Vitais • Exame Físico Geral • Avaliação Vascular • Ausculta Pulmonar e Cardíaca • Avaliação Postural • Exame Motor • Coordenação e Equilíbrio • Sensibilidade • Diagnóstico, Objetivos, Condutas e Evolução

---

Acadêmico(a): _____

RA / Matrícula: _____ **Turma:** _____

Docente responsável: _____

Paciente avaliado(a): _____

Data da avaliação: _____ **Local:** _____

> **A ficha de avaliação é um DOCUMENTO**
>
> A ficha de avaliação / prontuário do paciente é um documento e deve ser preenchida da forma mais completa e verdadeira possível. Expressões relatadas pelo paciente devem ser registradas entre aspas ou seguidas do termo SIC (segundo informações colhidas).

ORIENTAÇÕES PARA A AVALIAÇÃO

Etapas do processo de reabilitação

O processo de reabilitação segue as etapas abaixo. A coluna da direita indica em qual parte desta ficha cada etapa é registrada.

Nº	Etapa do processo de reabilitação	Onde registrar nesta ficha
1	Avaliação fisioterapêutica (anamnese + exame físico)	Partes 1 a 15
2	Diagnóstico cinético-funcional (fisioterapêutico)	Parte 16
3	Prognóstico	Parte 16
4	Objetivos do tratamento	Parte 16
5	Planejamento terapêutico – elaboração das condutas	Parte 16
6	Tratamento fisioterapêutico	Parte 17 (evolução diária)
7	Evolução do tratamento	Parte 17
8	Reavaliação	Parte 18
9	Alta fisioterapêutica	Parte 18

Ato terapêutico: postura do avaliador

Além da intervenção de tratamento, o profissional provoca reflexões de mudanças em pensamentos e comportamentos futuros, reconhecendo que muitas mudanças significativas acontecem fora do processo terapêutico.

Atitudes úteis e produtivas do terapeuta	Atitudes inúteis e prejudiciais do terapeuta
Demonstração de segurança, com autoridade.	Demonstrar dúvida, insegurança ou ansiedade.
Seriedade, sobriedade, serenidade, humildade e atenção.	Ostentação intelectual e narcisista.
Capacidade de dar amor baseado no tripé: consideração, respeito e carinho.	O desamor; a não existência do tripé citado.
Terapeuta “amigo” do paciente.	Terapeuta “professor” do paciente.
Honestidade científica e profissional.	Desonestidade.

Relação terapeuta – paciente – família

- Componentes cognitivos: do paciente e do terapeuta.
- Componente ético.
- Reações prejudiciais ao relacionamento: ansiedade, depressão, agressividade, desamor, desconsideração, falta de respeito, falta de atenção e falta de carinho.

Como conduzir a anamnese

- É o componente mais importante e mais difícil da propedêutica; reúne informações subjetivas, que devem ser as mais completas possíveis.
- Quanto maior o conhecimento fisiopatológico (sinais e sintomas), melhor a história colhida.
- Usar expressões no nível de instrução do paciente e não dar tom emocional à pergunta.
- Demonstrar tranquilidade e certa autoridade, sem agressões nos gestos ou ameaças de que o prognóstico é ruim.
- Dirigir as perguntas no sentido de verificar a veracidade das informações.
- Não aceitar diagnósticos elaborados ou comunicados pelo paciente ou acompanhantes.
- Registrar as falas do paciente entre aspas ou seguidas do termo SIC (segundo informações colhidas).

Cuidados durante o exame físico

- O exame físico deve ser completo, tecnicamente correto e compreendido durante a sua execução.
- Contato verbal esclarecedor e tranquilizante a respeito da sequência e das finalidades das técnicas.
- Aquecer as mãos e os instrumentos que serão utilizados; higienizar as mãos antes e depois.
- Respeito pelo corpo do paciente; postura séria, tecnicamente atenta e meticulosa.
- Bom senso e percepção do terapeuta, sempre atento e cordial: consolida a boa relação terapeuta-paciente.

Materiais necessários (checklist)

☐ Estetoscópio (diafragma e campânula)
☐ Esfigmomanômetro validado e calibrado
☐ Manguitos de tamanhos variados
☐ Termômetro digital ou infravermelho
☐ Relógio com segundos ou cronômetro
☐ Fita métrica
☐ Lápis dermográfico
☐ Martelo de reflexos (pincel e cabo metálico)
☐ Objeto pontiagudo descartável (agulha)
☐ Mecha de algodão
☐ Diapasão
☐ Compasso (discriminação de dois pontos)
☐ Objetos familiares (estereognosia)
☐ Fio de prumo / simetrógrafo
☐ Cones (marcha com obstáculos)
☐ Álcool 70% e papel-toalha

1. IDENTIFICAÇÃO E DADOS CLÍNICOS

1.1 Dados pessoais

Nome completo: _____

Data de nascimento: _____ **Idade:** _____ anos **Prontuário nº:** _____

Gênero: ☐ Feminino ☐ Masculino ☐ Outro: _____

Estado civil: ☐ Solteiro(a) ☐ Casado(a) / União estável ☐ Divorciado(a) ☐ Viúvo(a)

Cor / Raça: ☐ Branca ☐ Preta ☐ Parda ☐ Amarela ☐ Indígena

Nacionalidade: _____ **Naturalidade:** _____

Procedência: _____

Endereço: _____

Bairro: _____ **Cidade / UF:** _____

Telefone: _____ **Contato de emergência:** _____

Dominância: ☐ Destro ☐ Sinistro (canhoto) ☐ Ambidestro

Profissão / ocupação: _____

Situação profissional: ☐ Ativo(a) ☐ Afastado(a) ☐ Aposentado(a) ☐ Desempregado(a) ☐ Estudante

Grau de escolaridade (comunicação):
☐ Não alfabetizado ☐ Fundamental incompleto ☐ Fundamental completo
☐ Médio incompleto ☐ Médio completo ☐ Superior incompleto ☐ Superior completo
☐ Pós-graduação

Religião / Religiosidade: _____

1.2 Dados antropométricos

Peso: _____ kg **Altura:** _____ m **IMC:** _____ kg/m²

IMC = peso (kg) ÷ altura² (m). Referência saudável: 18 a 24 kg/m² (Diretriz Brasileira de Hipertensão, 2025).

1.3 Dados clínicos

Diagnóstico clínico (médico) – DC:

Médico responsável: _____ **CRM:** _____

Encaminhado por: _____ **Data:** _____

Queixa principal (QP): *registrar com as palavras do paciente, entre aspas ou seguida de SIC*

Expectativa do paciente em relação ao tratamento:

Diagnóstico clínico × diagnóstico cinético-funcional (exemplo da aula)

- **Diagnóstico clínico (médico):** Acidente Vascular Encefálico (AVE) à direita.
- **Diagnóstico cinético-funcional (fisioterapêutico):** Hemiplegia à esquerda.

2. ANAMNESE (HISTÓRIA CLÍNICA)

Tipo de anamnese: ☐ Ativa (relatada pelo paciente) ☐ Passiva (relatada por acompanhante) ☐ Ambas

Informante: _____ **Parentesco:** _____

2.1 História da Moléstia Atual (HMA) / História da Doença Atual (HDA)

Sintomas atuais: início, duração, evolução, fatores de melhora e de piora.

Início dos sintomas (data): _____ **Duração:** _____

Modo de início: ☐ Súbito ☐ Gradual

Evolução: ☐ Melhora ☐ Piora ☐ Estável ☐ Oscilante

Dor: ☐ Não ☐ Sim Local: _____ Intensidade (0 a 10): _____

Fatores de melhora: _____

Fatores de piora: _____

Descrição da HMA / HDA:

2.2 História da Moléstia Pregressa (HMP) / História da Doença Pregressa (HDP)

Passado fisiológico ou patológico, anterior à moléstia atual, que tenha relação com a QP.

Doenças associadas:

☐ Hipertensão arterial ☐ Diabetes mellitus ☐ Cardiopatias ☐ Doenças respiratórias
☐ Doenças vasculares (varizes, trombose) ☐ Doenças neurológicas
☐ Doenças osteomusculares ☐ Dislipidemia ☐ Outras

2.3 Histórico Familiar (HF)

A HMA pode ser auxiliada por elementos familiares.

☐ Hipertensão arterial ☐ Diabetes mellitus ☐ Cardiopatias ☐ Câncer
☐ Doenças neurológicas ☐ Doenças reumáticas ☐ Outras

2.4 Histórico Social (HS)

Tabagista: ☐ Não ☐ Sim ☐ Ex-tabagista Cigarros/dia: _____ Há quanto tempo: _____

Etilista: ☐ Não ☐ Sim ☐ Social ☐ Ex-etilista Frequência: _____

Atividade física: ☐ Sedentário(a) ☐ Ativo(a) Qual / frequência: _____

Qualidade do sono: ☐ Boa ☐ Regular ☐ Ruim Horas/noite: _____

Moradia: ☐ Casa térrea ☐ Sobrado / escadas ☐ Apartamento (elevador: sim / não)

Mora com: _____

Atividades sociais e de lazer: _____

2.5 Atividades de Vida Diária (AVD)

Assinale o nível de independência do paciente em cada atividade:

Atividade	Independente	Independente c/ dificuldade	Independência parcial	Dependente
Alimentação	☐	☐	☐	☐
Higiene pessoal	☐	☐	☐	☐
Banho	☐	☐	☐	☐
Vestuário (membros superiores)	☐	☐	☐	☐
Vestuário (membros inferiores)	☐	☐	☐	☐
Uso do banheiro	☐	☐	☐	☐
Transferências (cama / cadeira)	☐	☐	☐	☐
Locomoção / marcha	☐	☐	☐	☐
Subir e descer escadas	☐	☐	☐	☐

Legenda da funcionalidade (aula de Exame Motor)

- **Independente:** realiza sem auxílio, com facilidade.
- **Independente com dificuldade:** realiza sozinho, porém com dificuldades para a execução.
- **Independência parcial:** necessita do auxílio de terceiros para a execução.
- **Dependente:** não consegue realizar a atividade.

2.6 Atividades de Vida Prática / Profissional (AVP)

Quais atividades do dia a dia e do trabalho estão prejudicadas pela doença?

2.7 Tratamentos anteriores

Tratamento realizado	Período	Resultado obtido

2.8 Cirurgias anteriores

☐ Nenhuma ☐ Osteossíntese ☐ Prótese ☐ Marca-passo ☐ Piercing ☐ Outras

Cirurgia / implante	Data	Observações

2.9 Medicamentos em uso

Medicamento (qual)	Dose / horário	Para quê (indicação)

2.10 Exames complementares

☐ Exames de imagem (RX, TC, RM, US) ☐ Densitometria óssea ☐ Exames laboratoriais
☐ Outros

Exame	Data	Resultado / laudo

3. SINAIS VITAIS

Conceito

- Constituem os indicadores de saúde geral ou do estado fisiológico: Pressão Arterial (PA), Frequência Cardíaca (FC), Frequência Respiratória (FR) e Temperatura corporal (T°).
- São a etapa final da anamnese ou a etapa inicial do exame físico.
- **Atenção:** a criança não é um adulto pequeno — alguns sinais vitais apresentam valores diferentes de acordo com a faixa etária.

3.1 Quadro-resumo dos sinais vitais

Horário da aferição: _____ **Posição do paciente:** _____

Sinal vital	Valor aferido	Unidade	Referência (adulto)	Classificação
Pressão Arterial (PA)	____ / ____	mmHg	< 120 / 80	
Pressão Arterial Média (PAM)		mmHg	70 a 100	
Frequência Cardíaca (FC)		bpm	60 a 100	
Frequência Respiratória (FR)		rpm / ipm	12 a 20	
Temperatura (T°)		°C	36 a 37,5 (média 36,6)	

3.2 Pressão Arterial (PA)

Conceitos (aula de Pressão Arterial)

- Pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias. Reflete os efeitos do débito cardíaco (DC) e da resistência vascular periférica (RVP): PA = DC × RVP. Depende também do volume sanguíneo.
- O sangue circula normalmente em fluxo laminar; em vasos estreitos ou estenosados e altas velocidades, o fluxo torna-se turbulento.
- **Sístole:** contração dos ventrículos (sangue bombeado) — abertura das valvas aórtica e pulmonar e fechamento das valvas mitral e tricúspide.
- **Diástole:** relaxamento (sangue entra no coração) — fechamento das valvas aórtica e pulmonar e abertura das valvas mitral e tricúspide.
- **Medida direta:** cateter invasivo na artéria (radial, femoral), em tempo real, batimento a batimento; mostra PAS, PAD e PAM no monitor — apenas em ambiente hospitalar.
- **Medida indireta:** com esfigmomanômetro (aneroide ou digital) e estetoscópio; menos precisa que a direta.
- Unidade de medida: milímetros de mercúrio (mmHg).

Preparo do paciente (Diretriz Brasileira de Hipertensão, 2025)

☐ Braço nu, apoiado na altura do coração, com a palma da mão voltada para cima.

☐ Ambiente silencioso, com temperatura confortável.

☐ 30 minutos sem fumar ou ingerir alimentos/cafeína e 90 minutos sem praticar exercício físico.

☐ Sentado, com as costas apoiadas na cadeira, pernas descruzadas e pés apoiados no chão.

☐ Sentado por pelo menos 5 minutos, de bexiga vazia e sem falar.

☐ Roupas não devem garrotear o membro; não falar nem se mexer durante a aferição.

☐ Equipamento validado e periodicamente calibrado.

Dados da aferição

Membro: ☐ MSD ☐ MSE *(preferencialmente o braço dominante)*

Local: ☐ Braquial ☐ Radial ☐ Poplítea ☐ Tibial

Posição: ☐ Sentado ☐ Deitado ☐ Em pé

Equipamento: ☐ Manômetro aneroide ☐ Digital

Circunferência do braço (ponto médio acrômio–olécrano): _____ cm

Manguito utilizado: _____

Estimativa da PAS pelo método palpatório: _____ mmHg

Nível da PAS: palpando a artéria radial, fechar a válvula e insuflar o manguito lentamente até parar de sentir o pulso radial. Depois, esvaziar o manguito.

Medida	Horário	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)	Observações
1ª medida				
2ª medida				
3ª medida				
Média (2ª e 3ª)				

Realizar três medidas com intervalo de 1 minuto e usar a média das duas últimas. Se houver diferença > 10 mmHg, realizar medidas adicionais.

PAM = (PAS + 2 × PAD) ÷ 3 =: _____ mmHg

Referência da PAM: 70 a 100 mmHg.

Classificação da PA (Diretriz Brasileira de Hipertensão, 2025)

	Classificação	PAS (mmHg)		PAD (mmHg)
☐	**Hipotensão**	< 90	/	< 60
☐	**PA normal (normotenso)**	< 120	e	< 80
☐	**Pré-hipertensão**	120 – 139	e/ou	80 – 89
☐	**HA estágio 1**	140 – 159	e/ou	90 – 99
☐	**HA estágio 2**	160 – 179	e/ou	100 – 109
☐	**HA estágio 3**	≥ 180	e/ou	≥ 110

- Quando a PAS e a PAD estiverem em categorias diferentes, utiliza-se a maior para a classificação.
- Diagnóstico de hipertensão arterial: PA de consultório ≥ 140 e/ou 90 mmHg em 2 ocasiões. MAPA ou MRPA sempre que possível.

Sons de Korotkoff (referência)

Fase	Descrição
I	Primeiros sons fracos, como leves pancadas, que aumentam gradualmente de intensidade. Indicação inicial da pressão sistólica (PAS).
II	Os sons têm qualidade de sopro ou de assobio.
III	Sons nítidos e mais altos do que os anteriores.
IV	Abafamento distinto dos sons. Indicação inicial da pressão diastólica.
V	Os sons desaparecem totalmente — “segunda fase da pressão diastólica” (PAD).

As fases I e V são as mais importantes para a determinação da PA.

Passo a passo da medida em consultório

1. Determinar a circunferência do braço no ponto médio entre acrômio e olécrano e selecionar o manguito adequado (quadro abaixo).

2. Colocar o manguito sem folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital, centralizando o meio da bolsa inflável sobre a artéria braquial.
3. Estimar o nível da PAS (método palpatório).
4. Colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio, sem compressão excessiva, na fossa cubital.
5. Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da PAS.
6. Realizar a deflação lentamente (cerca de 2 mmHg/s).
7. Determinar a PAS na ausculta do primeiro som (fase I) e a PAD no desaparecimento dos sons (fase V).
8. Realizar três medidas, com intervalo de 1 minuto, e utilizar a média das duas últimas.

Dimensões do manguito conforme a circunferência do braço (Quadro 3 – Diretriz 2025)

Circunferência do braço (cm)	Denominação do manguito	Largura do manguito (cm)	Comprimento da bolsa (cm)
≤ 6	Recém-nascido	3	6
6 – 15	Criança	5	15
16 – 21	Infantil	8	21
22 – 26	**Adulto pequeno**	10	24
27 – 34	**Adulto**	13	30
35 – 44	Adulto grande	16	38
45 – 52	Coxa	20	42

Fatores que podem ter interferido na aferição

☐ Estado emocional ☐ Posição do paciente ☐ Fatores nutricionais
☐ Atividade física recente ☐ Local de aferição ☐ Efeito do jaleco branco

Fatores de risco para hipertensão arterial presentes

☐ Idade ☐ Sexo ☐ Etnia ☐ Genéticos ☐ Sobrepeso / obesidade ☐ Sedentarismo
☐ Ingestão de (+) sódio e (–) potássio ☐ Álcool ☐ Medicamentos / drogas
☐ Distúrbios do sono ☐ Psicossociais ☐ Urbanização / poluição ☐ Ambientais

Orientações de prevenção da HA fornecidas ao paciente

☐ Não fumar ☐ Dieta saudável (DASH) ☐ Controle de peso (IMC 18–24 kg/m²)
☐ Redução da ingestão de sal ☐ Aumento da ingestão de potássio ☐ Atividade física regular
☐ Controle do uso de álcool ☐ Qualidade e tempo de sono
☐ Gerenciamento do estresse / espiritualidade ☐ Conexões sociais positivas

3.3 Frequência Cardíaca (FC)

Conceitos (aula de Temperatura e FC)

- É a velocidade do ciclo cardíaco, medida pelo número de contrações do coração por minuto; indica o ritmo com que o coração está batendo.
- Pulso: movimento do sangue em uma artéria, que pode ser palpado em vários locais do corpo.
- Origem da FC — condução elétrica do coração: nó sinusal → vias internodais → nó atrioventricular (A-V) → feixe de His → ramos direito e esquerdo → fibras de Purkinje.
- Ritmo regular = ritmo sinusal. Arritmia = falta de ritmo nos batimentos, por mau funcionamento do sistema elétrico de condução.
- O exame físico é soberano aos equipamentos digitais: o oxímetro pode interpretar valores errados em caso de arritmias.

Técnica

1. Higienizar as mãos.
2. Utilizar relógio que marque os segundos ou cronômetro.
3. Colocar duas ou três polpas digitais sobre a artéria — não utilizar o próprio polegar.
4. Usar preferencialmente a artéria radial ou a artéria carótida.
5. Evitar pressão excessiva, que pode ocluir a artéria.
6. Contar mentalmente cada batimento palpado durante 1 minuto.
7. Registrar o resultado em batimentos por minuto (bpm).

Registro

Artéria utilizada: ☐ Radial ☐ Carótida ☐ Braquial ☐ Outra: _____

Lado: ☐ Direito ☐ Esquerdo

FC: _____ bpm **Tempo de contagem:** _____

Ritmo: ☐ Regular (sinusal) ☐ Irregular (arritmia)

Classificação: ☐ Bradicardia (ritmo lento) ☐ Normocardia ☐ Taquicardia (ritmo rápido)

Valores de referência da FC por idade (American Heart Association – PALS)

Idade	FC em vigília (bpm)	FC em sono (bpm)
Recém-nascido a 3 meses	85 a 205	80 a 160
3 meses a 2 anos	100 a 190	75 a 160
2 a 10 anos	60 a 140	60 a 90
> 10 anos (e adultos)	**60 a 100**	50 a 90

Locais de aferição do pulso arterial

- Artérias temporal, facial, carótida, braquial, radial, ulnar, femoral, poplítea, tibial posterior e dorsal do pé (pediosa).

3.4 Frequência Respiratória (FR)

Conceitos (aula de Frequência Respiratória)

- **Frequência:** número de incursões respiratórias por minuto. **Ritmo:** regularidade do padrão.
- A mensuração é feita pela observação ou pelo tato do movimento do tórax, do abdômen ou de ambos.
- Diferente da FC, o paciente consegue alterar a FR voluntariamente e mascarar o resultado — por isso a contagem é feita “disfarçada”.
- Unidade de medida: respirações por minuto (rpm) ou incursões por minuto (ipm).

Técnica

1. Higienizar as mãos.
2. Utilizar relógio que marque os segundos ou cronômetro.
3. Simular a mensuração do pulso radial, com o antebraço do paciente apoiado sobre o abdômen dele, ou colocar a outra mão sobre o tórax.
4. Observar e sentir pelo tato o movimento do tórax do paciente.
5. Contar as respirações durante 1 minuto.

Registro

FR: _____ rpm (ipm)

Ritmo: ☐ Regular ☐ Irregular

Padrão respiratório: ☐ Torácico ☐ Abdominal ☐ Misto (tóraco-abdominal)

Classificação: ☐ Eupneia (12–20 rpm) ☐ Bradipneia (< 12 rpm) ☐ Taquipneia (> 24 rpm) ☐ Apneia (ausência de fluxo > 10 s)

Valores normais da FR por idade (Ministério da Saúde, 2003)

Idade	FR normal
< 2 meses	até 60 rpm
2 meses a 1 ano	até 50 rpm
1 a 5 anos	até 40 rpm
5 a 8 anos	até 30 rpm
Adultos	**12 a 20 rpm (eupneia)**

3.5 Temperatura Corporal (T°)

Conceitos (aula de Temperatura e FC)

- Indica a intensidade ou o grau de calor dentro do corpo; representa o equilíbrio entre o calor produzido e o calor perdido.
- Nos seres humanos permanece relativamente constante, independente da temperatura ambiente.
- É regulada pelos centros reguladores do hipotálamo — o “termostato hipotalâmico”.
- Valor médio mais aceito: 36,6 °C. Unidade no Brasil: graus Celsius (°C).
- Desde 2019 é proibida a fabricação, importação e comercialização de termômetros e aparelhos de pressão com mercúrio.

Técnica (termômetro digital axilar)

1. Higienizar o termômetro antes e após cada utilização.
2. Ligar o termômetro e verificar se a tela mostra zero ou apenas o símbolo “°C”.
3. Colocar a ponta do termômetro debaixo da axila e aguardar alguns segundos até o sinal sonoro.
4. Retirar o termômetro e verificar o valor da temperatura na tela.

Registro

Termômetro: ☐ Digital ☐ Infravermelho

Local: ☐ Axila ☐ Boca ☐ Ouvido ☐ Testa ☐ Ânus

Temperatura: _____ °C

Classificação: ☐ Hipotermia (≤ 35) ☐ Normal (36 – 37,5) ☐ Febre (37,5 – 39,5) ☐ Febre alta (39,5 – 41) ☐ Hipertermia (≥ 41)

Temperatura de febre conforme o local do corpo

Local do corpo	Temperatura de febre
Axila	Acima de 37,6 °C
Ânus	Acima de 38 °C
Boca	Acima de 37,5 °C
Ouvido	Acima de 37,8 °C
Testa	Acima de 37,8 °C (crianças com 4 anos ou mais)

4. EXAME FÍSICO GERAL

Conceito (aula de Processo de Avaliação)

- Etapa que segue a anamnese. Refere-se à coleta de informações básicas que, em conjunto, definem o aspecto geral e específico do paciente; fornece evidências objetivas.
- **Inspeção:** técnica básica que utiliza a visão; finalidade e aplicação extremamente amplas.
- **Palpação:** utiliza a sensibilidade tátil para examinar as características das estruturas normais e anormais.
- **Ausculta:** utiliza a audição para detectar sons normais e anormais produzidos pelo funcionamento dos órgãos (Partes 6 e 7).
- **Exame físico específico:** testes, manobras, sinais e outros (Partes 8 a 15).

4.1 Inspeção geral

Estado geral: ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Consciente e orientado(a): ☐ Sim ☐ Não

Chegou ao atendimento: ☐ Deambulando sem auxílio ☐ Com dispositivo auxiliar ☐ Cadeira de rodas ☐ Maca

Dispositivo auxiliar (bengala, muletas, andador…): _____

Pele

Coloração: ☐ Normocorada ☐ Palidez ☐ Hiperemia ☐ Cianose ☐ Icterícia

Outros achados: ☐ Cicatrizes ☐ Edema ☐ Hematomas ☐ Úlceras / feridas ☐ Manchas

Local dos achados: _____

Face e fácies (expressão fisionômica)

Expressão do estado psicológico:

☐ Dor ☐ Medo ☐ Ansiedade ☐ Aflição ☐ Apatia ☐ Indiferença ☐ Triste ☐ Deprimida ☐ Alegre ☐ Atenciosa ☐ Raiva ☐ Outra: _____

Fácies característica de doença orgânica:

☐ Ausente ☐ Paralisia facial ☐ Parkinsoniana ☐ Síndrome de Down ☐ Outra: _____

Outras observações da inspeção:

4.2 Palpação

Temperatura local da pele: ☐ Normal ☐ Aumentada ☐ Diminuída

Edema: ☐ Ausente ☐ Presente Local: _____

Região palpada	Achados (pontos dolorosos, tensão, nódulos, crepitação…)

5. AVALIAÇÃO VASCULAR

Conceitos (aula de Avaliação Vascular)

- A avaliação dos pulsos arteriais compõe o exame físico e compreende a pesquisa de um conjunto de parâmetros.
- Pulso: expressão do “choque” ondulatório sempre palpável; corresponde à pressão da ejeção sistólica ventricular transmitida à parede elástica das grandes artérias até as da microcirculação. A distensibilidade e a velocidade diminuem à medida que o calibre arterial diminui.
- Capilares: permitem a troca entre o sangue e os tecidos.

Frequência	Ritmo	Amplitude	Pulsatilidade
Número de batimentos por minuto.	Amplitudes iguais com intervalos também iguais.	Depende do grau da ejeção ventricular sistólica.	Presença ou não do pulso.

5.1 Sinais e sintomas que indicam a avaliação vascular

☐ Dor nas pernas ou fraqueza durante o esforço (claudicação)
☐ Edema
☐ Dor, sensibilidade, vermelhidão ou calor na perna
☐ Pele pálida e fria, podendo ser acinzentada ou azulada
☐ Dor no pé
☐ Dormência ou formigamento

Condições associadas:

☐ Aterosclerose ☐ Aneurisma ☐ Trombo ou embolia ☐ Condições inflamatórias
☐ Varizes

5.2 Palpação dos pulsos arteriais

Regras da semiotécnica

- Palpação simétrica das artérias de mesmo nome (comparar direito × esquerdo).
- Realizar com o mínimo de compressão.
- Utilizar mais de uma polpa digital, exceto o polegar, percorrendo tronco e membros e pesquisando a simetria.

Legenda: P = presente / normal D = diminuído A = ausente

Artéria	Local de palpação	Direito	Esquerdo	Simétrico
Carótida	Borda interna do músculo esternocleidomastóideo	☐ P ☐ D ☐ A	☐ P ☐ D ☐ A	☐
Subclávia	Por trás e abaixo da clavícula	☐ P ☐ D ☐ A	☐ P ☐ D ☐ A	☐
Braquial	Medialmente ao tendão do músculo bíceps braquial	☐ P ☐ D ☐ A	☐ P ☐ D ☐ A	☐
Radial	Medialmente ao processo estiloide do rádio	☐ P ☐ D ☐ A	☐ P ☐ D ☐ A	☐
Ulnar	Lateralmente ao processo estiloide da ulna	☐ P ☐ D ☐ A	☐ P ☐ D ☐ A	☐
Femoral	Ponto médio entre a sínfise púbica e a EIAS, no trígono femoral	☐ P ☐ D ☐ A	☐ P ☐ D ☐ A	☐
Poplítea	Centro da face posterior do joelho, em ligeira flexão	☐ P ☐ D ☐ A	☐ P ☐ D ☐ A	☐
Tibial posterior	Por trás do maléolo medial	☐ P ☐ D ☐ A	☐ P ☐ D ☐ A	☐
Tibial anterior	Face anterior do tornozelo, junto aos tendões do músculo tibial anterior	☐ P ☐ D ☐ A	☐ P ☐ D ☐ A	☐
Pediosa (dorsal do pé)	No pé, por dentro do tendão do tibial anterior	☐ P ☐ D ☐ A	☐ P ☐ D ☐ A	☐
Aorta	Na fúrcula esternal	☐ P ☐ D ☐ A		
Aorta abdominal	Do epigástrio até dois dedos abaixo do umbigo	☐ P ☐ D ☐ A		

Características do pulso radial

Frequência: _____ bpm

Ritmo: ☐ Regular ☐ Irregular

Amplitude: ☐ Ampla ☐ Normal ☐ Reduzida

Pulsatilidade: ☐ Presente ☐ Ausente

5.3 Tempo de Enchimento Capilar (TEC)

Técnica

- Avalia a perfusão periférica: a capacidade de um leito capilar distal recuperar a perfusão após uma pressão.
- Pressionar a extremidade distal (leito ungueal) por até 10 segundos, até que a pele fique branca; soltar e contar o tempo de retorno da coloração.
- **TEC < 3 segundos = normal. TEC > 3 segundos = alterado.**

Local	Direito (s)	Esquerdo (s)	Resultado
Membros superiores (leito ungueal da mão)			☐ Normal ☐ Alterado
Membros inferiores (leito ungueal do pé)			☐ Normal ☐ Alterado

Observações da avaliação vascular:

6. AUSCULTA PULMONAR

Conceitos (aula de Ausculta Pulmonar)

- Ventilação e troca gasosa: (1) ventilação pulmonar — entrada e saída do ar entre o meio ambiente e os alvéolos; (2) hematose — difusão de O_2 e CO_2 entre alvéolos e sangue; (3) transporte de O_2 e CO_2 no sangue; (4) utilização do O_2 no metabolismo celular.
- Pulmões: órgãos esponjosos envolvidos pela pleura e divididos em lobos — o pulmão direito tem 3 lobos e o esquerdo, 2.
- Alvéolos: unidade funcional do pulmão, onde ocorre a hematose (membrana alvéolo-capilar).
- Ausculta pulmonar: método de exploração funcional dos sons pulmonares, produzidos no interior das vias aéreas pela passagem do fluxo aéreo inspiratório e expiratório.

6.1 Condições para uma boa ausculta (checklist)

☐ Ambiente silencioso, livre de ruídos externos.

☐ Paciente colaborativo e, preferencialmente, sentado.

☐ Estetoscópio completo (diafragma / campânula) e audição normal do examinador.

☐ Tórax desnudo — não auscultar sobre seda ou camiseta grossa (geram ruídos que induzem ao erro).

☐ Paciente respira pela boca entreaberta, com inspiração e expiração de média amplitude, tranquila e profunda, evitando ruídos intencionais.

Padronização da técnica

1. Percorrer com o estetoscópio toda a superfície do tórax, sempre comparando os dois hemitórax.
2. Começar pela região anterior, do ápice à base.
3. Repetir da mesma forma nas regiões posterior e lateral.
4. Em cada ponto, prestar atenção nas duas fases respiratórias (inspiração e expiração).

6.2 Sons pulmonares (referência)

Som	Característica
Murmúrio vesicular (MV)	Som pulmonar fisiológico: suave, de entrada e saída do ar (lembra o barulho do mar).
Sibilos	Ruído adventício por ponto de obstrução ou vibração da via aérea (espasmo, edema, corpo estranho, secreção).
Roncos	Ruído adventício por obstrução ou vibração da via aérea (secreção).
Estridor laríngeo	Som intenso, que às vezes pode ser ouvido mesmo sem o estetoscópio.
Estertores crepitantes (EC)	Som de líquido no tecido pulmonar (ex.: edema pulmonar).

6.3 Registro da ausculta por região

Legenda — MV: + presente/normal D diminuído Ø abolido. **RA:** — ausente S sibilos R roncos ES estridor EC estertores crepitantes

Região	Hemitórax DIREITO		Hemitórax ESQUERDO	
	MV	RA	MV	RA
Anterior – ápice				
Anterior – terço médio				
Anterior – base				
Lateral – superior				
Lateral – inferior (base)				
Posterior – ápice				
Posterior – terço médio				
Posterior – base				

6.4 Evolução da ausculta pulmonar

Murmúrio vesicular: ☐ Presente ☐ Diminuído ☐ Abolido

Ruídos adventícios: ☐ Ausentes ☐ Sibilos ☐ Roncos ☐ Estridor ☐ Estertores crepitantes

Localização: ☐ Ápice D ☐ Ápice E ☐ Base D ☐ Base E ☐ Ambos hemitórax ☐ Globalmente

Registro final da AP:

_____

_____

Como evoluir uma ausculta pulmonar (exemplos)

- Há MV? Presente, diminuído ou abolido? Há ruídos adventícios? Quais? Em qual região?
- **Ausculta fisiológica:** “MV+ sem RA”.
- **Com ruídos adventícios:** “MV+ com roncos em base D” / “MV+ com sibilos em AHTX” / “MV+ com EC globalmente”.
- **Com redução do MV:** “MV diminuído em base E”.

7. AUSCULTA CARDÍACA

Conceitos (aula de Ausculta Cardíaca)

- O coração é formado por duas bombas: o VD bombeia o sangue para os pulmões (pequena circulação) e o VE bombeia o sangue que sai dos pulmões para o resto do corpo (grande circulação).
- **Sístole:** contração ventricular e saída do sangue; fechamento das valvas A-V (mitral e tricúspide).
- **Diástole:** relaxamento ventricular e entrada do sangue; fechamento das valvas semilunares (aórtica e pulmonar).
- As bulhas são sons gerados pelo impacto do sangue nas estruturas cardíacas e nos grandes vasos, associados ao fechamento das valvas.

Bulha	Característica
B1 — "TUM"	Ocorre na sístole; fechamento das valvas mitral e tricúspide (A-V). B1 = M1 + T1.
B2 — "TÁ"	Ocorre na diástole; fechamento das valvas aórtica e pulmonar (semilunares). B2 = A2 + P2.
B3	Acessória; ocorre na protodiástole (início da diástole) quando o ventrículo está dilatado. Pode indicar disfunção ventricular em adultos.
B4	Acessória; provocada pelo enchimento ventricular aumentado — brusca desaceleração do fluxo na contração atrial no final da diástole.
Ritmo de galope	Ritmo patológico: B4 – B1 – B2 – B3 em sucessão rápida.

7.1 Focos de ausculta cardíaca

Os focos não ficam anatomicamente posicionados sobre as respectivas valvas.

Foco	Localização	B1 e B2 audíveis	Fonese	Bulhas acessórias	Sopros / cliques
Aórtico	2º espaço intercostal DIREITO, junto ao esterno	☐ Sim ☐ Não	☐ Normo ☐ Hiper ☐ Hipo	☐ Ausentes ☐ B3 ☐ B4	☐ Ausente ☐ Presente
Pulmonar	2º espaço intercostal ESQUERDO, junto ao esterno	☐ Sim ☐ Não	☐ Normo ☐ Hiper ☐ Hipo	☐ Ausentes ☐ B3 ☐ B4	☐ Ausente ☐ Presente
Tricúspide	5º espaço intercostal esquerdo, junto ao esterno (sobre o VD)	☐ Sim ☐ Não	☐ Normo ☐ Hiper ☐ Hipo	☐ Ausentes ☐ B3 ☐ B4	☐ Ausente ☐ Presente
Mitral	5º espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular (ponta do coração – VE)	☐ Sim ☐ Não	☐ Normo ☐ Hiper ☐ Hipo	☐ Ausentes ☐ B3 ☐ B4	☐ Ausente ☐ Presente

7.2 Sequência da ausculta cardíaca

1. Avaliação das bulhas

Distingue B1 de B2: ☐ Sim ☐ Não

Fonese: ☐ Normofonéticas ☐ Hiperfonese (aumento da sonoridade)
☐ Hipofonese (redução da sonoridade)

Terceira bulha (B3): ☐ Ausente ☐ Presente

Quarta bulha (B4): ☐ Ausente ☐ Presente

2. Ritmo e frequência cardíaca

Ritmo: ☐ Regular (rítmico) ☐ Irregular (arrítmico) ☐ Ritmo de galope

Tempos: ☐ 2 tempos ☐ 3 tempos ☐ 4 tempos FC: _____ bpm

3. Cliques e estalidos

☐ Ausentes ☐ Presentes Foco: _____

4. Sopros

☐ Ausentes ☐ Presentes Foco: _____

5. Ruídos acessórios (atrito pericárdico)

☐ Ausente ☐ Presente

7.3 Evolução da ausculta cardíaca

Evolução de ausculta cardíaca fisiológica

- **BRNF 2T SS** = Bulhas Rítmicas NormoFonéticas, em 2 Tempos, Sem Sopros.
- Patologias valvares que alteram a ausculta: calcificação e estenose; prolapso.

8. AVALIAÇÃO POSTURAL

Conceitos (aula de Avaliação Postural)

- Coluna vertebral: cervical (7 vértebras), torácica (12), lombar (5), sacral (5) e coccígea (4). Curvaturas fisiológicas: 2 lordoses (cervical e lombar) e 2 cifoses (torácica e sacral).
- Postura: composto das posições das diferentes articulações do corpo em um dado momento.
- Postura correta: posição em que um mínimo de estresse é aplicado em cada articulação — alinhamento com eficiência fisiológica e biomecânica máxima, minimizando as sobrecargas causadas pela gravidade.
- Para melhorar o alinhamento postural: identificação da alteração → correção da postura → prevenção da evolução → manutenção da postura correta → conscientização da boa postura.

8.1 Critérios para a avaliação

☐ Paciente em pé, posicionado de forma que o fisioterapeuta consiga dar a volta em todo o seu corpo.

☐ Vestimenta: top e short para mulheres; sunga ou bermuda acima dos joelhos para homens.

☐ Recursos: fio de prumo (linha vertical da gravidade, aplicado nas vistas lateral e posterior) e/ou simetrógrafo.

8.2 Queixas e causas de disfunção postural

Algias da coluna: ☐ Ausentes ☐ Cervicalgia ☐ Dorsalgia ☐ Lombalgia

As algias da coluna afetam 70% a 80% da população: lombalgia 62% (L4-L5 e L5-S1 os níveis mais afetados), cervicalgia 36% e dorsalgia 2%.

Possíveis causas identificadas:

☐ Desgaste profissional e/ou ocupacional ☐ Cansaço / estresse ☐ Hereditariedade
☐ Patologias ☐ Hábitos posturais ☐ Fator idade (geriatria)

8.3 Fio de prumo — vista lateral

Segmento	Ponto por onde a linha deve passar	Vista lateral DIREITA	Vista lateral ESQUERDA
Cabeça	Lobo da orelha	☐ Alinhado ☐ Anterior ☐ Posterior	☐ Alinhado ☐ Anterior ☐ Posterior
Ombro	Centro da articulação do ombro	☐ Alinhado ☐ Anterior ☐ Posterior	☐ Alinhado ☐ Anterior ☐ Posterior
Quadril	Trocânter maior do fêmur	☐ Alinhado ☐ Anterior ☐ Posterior	☐ Alinhado ☐ Anterior ☐ Posterior
Joelho	Posteriormente à patela	☐ Alinhado ☐ Anterior ☐ Posterior	☐ Alinhado ☐ Anterior ☐ Posterior
Pé	Anteriormente ao maléolo lateral	☐ Alinhado ☐ Anterior ☐ Posterior	☐ Alinhado ☐ Anterior ☐ Posterior

8.4 Fio de prumo — vista posterior

Segmento	Ponto por onde a linha deve passar	Achado
Cabeça	Protuberância occipital	☐ Alinhado ☐ Desvio à D ☐ Desvio à E
Coluna	Processo espinhoso de C7	☐ Alinhado ☐ Desvio à D ☐ Desvio à E
Quadril	Fenda glútea	☐ Alinhado ☐ Desvio à D ☐ Desvio à E
Joelhos	Espaço entre as bordas mediais	☐ Alinhado ☐ Desvio à D ☐ Desvio à E
Pés	Metade do espaço entre os calcanhares	☐ Alinhado ☐ Desvio à D ☐ Desvio à E

8.5 Alterações posturais por vista

Segmento	Achados
VISTA ANTERIOR	
Cabeça	☐ Simétrica ☐ Inclinada à ____ ☐ Rodada à ____
Ombros	☐ Simétricos ☐ Elevação ☐ Assimétricos _____ mais baixo
Clavículas	☐ Simétricas ☐ Assimétricas _____ mais baixa
Triângulo de Tales	☐ Simétrico ☐ Maior à _____
EIAS	☐ Simétricas ☐ Assimétricas _____ mais baixa

Segmento	Achados
Joelhos	☐ Simétricos ☐ Valgo ☐ Varo
Patelas	☐ Simétricas ☐ Lateralizada ☐ Medializada
Pés	☐ Simétricos ☐ Plano ☐ Cavo
VISTA LATERAL	
Cabeça	☐ Simétrica ☐ Anteriorizada ☐ Posteriorizada
Ombros	☐ Simétricos ☐ Protusão ☐ Retração
Coluna cervical	☐ Simétrica ☐ Hiperlordose ☐ Retificação
Coluna torácica	☐ Simétrica ☐ Hipercifose ☐ Retificação
Coluna lombar	☐ Simétrica ☐ Hiperlordose ☐ Retificação
Pelve	☐ Simétrica ☐ Anteroversão ☐ Retroversão
Joelhos	☐ Simétricos ☐ Recurvado (hiperextendido)
VISTA POSTERIOR	
Cabeça	☐ Simétrica ☐ Inclinada à ____
Ombros	☐ Simétricos ☐ Assimétricos _____ mais baixo
Escápulas	☐ Simétricas ☐ Assimétricas ☐ Alada _____ mais baixa
Coluna (escoliose)	☐ Ausente ☐ Em C ☐ Em S Região / convexidade: _____
Presença de giba	☐ Não ☐ Sim Lado: _____
Triângulo de Tales	☐ Simétrico ☐ Maior à _____

Definições das principais alterações

- **Hipercifose:** aumento da curvatura torácica; pode estar associada à protusão dos ombros. Analisada em vista lateral.
- **Hiperlordose:** aumento da curvatura cervical e/ou lombar. A lordose lombar relaciona-se com a obliquidade pélvica anteroposterior (cerca de 20°); acima disso desloca o centro de gravidade e altera as outras curvaturas. Analisada em vista lateral.
- **Escoliose:** curvatura anormal da coluna com desvio lateral não fisiológico; em C (curva única) ou em S (com compensação). Analisada em vista anteroposterior / posteroanterior.
- **Triângulo (ângulo) de Tales:** triângulo imaginário entre a porção lateral do tronco e a parte interna do membro superior.

8.6 Conclusão da avaliação postural

9. EXAME MOTOR: TROFISMO E PERIMETRIA

9.1 Trofismo (massa muscular)

Conceitos (aula de Trofismo, Perimetria e Manobras Deficitárias)

- Trofismo corresponde ao volume de massa muscular existente. Aumento de massa = hipertrofia; redução de massa = hipotrofia.
- É avaliado por meio da inspeção (observação visual), da palpação e da perimetria.

Causas de HIPERTROFIA	Causas de HIPOTROFIA
Treinamento de força e resistência Sobrecarga funcional Genética	Desuso, imobilização Paraplegia ou paresia Internações prolongadas Desnutrição Envelhecimento Doenças neuromusculares

Resultado da inspeção e palpação

Segmento	Trofismo	Músculos / região
Membro superior direito	☐ Normotrofia ☐ Hipertrofia ☐ Hipotrofia	
Membro superior esquerdo	☐ Normotrofia ☐ Hipertrofia ☐ Hipotrofia	
Membro inferior direito	☐ Normotrofia ☐ Hipertrofia ☐ Hipotrofia	
Membro inferior esquerdo	☐ Normotrofia ☐ Hipertrofia ☐ Hipotrofia	
Tronco	☐ Normotrofia ☐ Hipertrofia ☐ Hipotrofia	

9.2 Perimetria

Como realizar

- Mensuração de perímetros corporais pré-determinados (perímetro = linha de contorno), com fita métrica.
- Utilizada para verificar o trofismo e, nas reavaliações, constatar a evolução do paciente.
- A mensuração deve ser sempre BILATERAL.
- Demarcar com lápis dermográfico os pontos onde será medido o perímetro, especificando de quantos em quantos centímetros.

Intervalo utilizado entre os pontos: _____ cm

Membros superiores

Segmento	Ponto de referência	Distância do ponto	Direito (cm)	Esquerdo (cm)	Diferença (cm)
Braço	☐ Linha axilar ☐ Olécrano ☐ Fossa cubital	_____ cm			
		_____ cm			
		_____ cm			
		_____ cm			
Antebraço	☐ Olécrano ☐ Fossa cubital (linha articular do cotovelo)	_____ cm			
		_____ cm			
		_____ cm			
		_____ cm			

Membros inferiores

Segmento	Ponto de referência	Distância do ponto	Direito (cm)	Esquerdo (cm)	Diferença (cm)
Coxa	☐ Virilha ☐ Bordo superior da patela (base)	_____ cm			
		_____ cm			
		_____ cm			
		_____ cm			
Perna	☐ Bordo inferior da patela (ápice) ☐ Maléolos	_____ cm			
		_____ cm			
		_____ cm			
		_____ cm			

Interpretação da perimetria:

10. EXAME MOTOR: FORÇA MUSCULAR E MANOBRAS DEFICITÁRIAS

10.1 Teste de Força Muscular Manual

Investigação da força da musculatura esquelética dos membros e do tronco. Registre o grau (0 a 5) de cada grupo muscular, sempre comparando os dois lados.

Grau	Descrição	Classificação
5	Movimento completo contra a gravidade e contra resistência máxima (força normal).	**Normal**
4	Movimento completo contra a gravidade e contra resistência moderada.	**Paresia (redução da força)**
3	Movimento completo contra a gravidade, sem resistência.	
2	Movimento completo com a gravidade eliminada.	
1	Contração muscular visível ou palpável, sem movimento articular.	
0	Ausência de contração muscular.	**Plegia (ausência de força)**

Classificação da aula: Normal = 5; Paresia = 4, 3, 2, 1; Plegia = 0. Descrição dos graus conforme a escala de força muscular manual (Medical Research Council / Kendall).

Articulação	Grupo muscular	Direito (0–5)	Esquerdo (0–5)
Ombro	Flexores		
	Extensores		
	Abdutores		
	Adutores		
	Rotadores internos		
	Rotadores externos		
Cotovelo	Flexores		
	Extensores		
Antebraço	Pronadores		
	Supinadores		
Punho	Flexores		
	Extensores		
Mão	Preensão palmar (flexores dos dedos)		
	Extensores dos dedos		
Quadril	Flexores		

Articulação	Grupo muscular	Direito (0–5)	Esquerdo (0–5)
	Extensores		
	Abdutores		
	Adutores		
	Rotadores internos		
	Rotadores externos		
Joelho	Flexores		
	Extensores		
Tornozelo	Dorsiflexores		
	Plantiflexores		
Tronco	Flexores (abdominais)		
	Extensores		

Força muscular × funcionalidade

☐ Independente ☐ Independente com dificuldade ☐ Independência parcial ☐ Dependente

Independente: realiza sem auxílio, com facilidade • Independente com dificuldade: dificuldades na execução • Independência parcial: necessita de auxílio de terceiros • Dependente: não consegue realizar a atividade.

10.2 Manobras deficitárias

Orientações gerais

- Avaliam pequenos déficits neurológicos e motores de paralisia e fraqueza (podem complementar o teste de força).
- Realizar, de preferência, com os olhos do paciente fechados.
- Manter a posição de 30 segundos a 1 minuto; o ideal é o membro permanecer parado o tempo todo.
- Observar oscilações de movimentações distais e proximais do membro avaliado.

Manobra	Posição e execução	Resultado	Observações (oscilação, queda lenta ou abrupta)
Prova de Raimiste (MMSS)	Decúbito dorsal; cotovelos a 90° de flexão, antebraços e mãos em posição neutra, dedos em abdução.	☐ Negativa ☐ Positiva à D ☐ Positiva à E	
Prova de Mingazzini (MMSS)	Sentado; ombros a 90° de flexão, em pronação ou supinação. Observar oscilações e queda de um dos membros (hemiparesia ou hemiplegia).	☐ Negativa ☐ Positiva à D ☐ Positiva à E	
Prova de Mingazzini (MMII)	Decúbito dorsal; quadris e joelhos a 90° de flexão, MMSS ao lado do corpo, por cerca de 1 minuto. Observar oscilações, queda lenta ou abrupta.	☐ Negativa ☐ Positiva à D ☐ Positiva à E	
Queda dos MMII em abdução (MMII)	Pés apoiados no tablado, nem muito afastados nem se tocando; os joelhos não devem se tocar. Observar se os MMII caem em abdução.	☐ Negativa ☐ Positiva à D ☐ Positiva à E	
Prova do pé (MMII)	Decúbito dorsal. Se houver deficiência dos rotadores internos do quadril, o pé cai externamente (“pé de cadáver”).	☐ Negativa ☐ Positiva à D ☐ Positiva à E	
Prova de Barré (MMII)	Decúbito ventral; joelhos a 90° de flexão. Observar oscilações e queda.	☐ Negativa ☐ Positiva à D ☐ Positiva à E	

11. EXAME MOTOR: TÔNUS MUSCULAR

Conceitos (aula de Tônus Muscular)

- Estado de excitabilidade do sistema nervoso que controla ou influencia os músculos esqueléticos.
- Estado de contração mínima e permanente presente nos músculos quando relaxados voluntariamente.
- Responsável pela forma, relevo e consistência dos músculos em repouso e pela resistência aos movimentos passivos.
- **Tônus × trofismo:** tônus é o estado de tensão (leve contração) mantida mesmo em repouso; trofismo é o volume de massa muscular.

11.1 Como avaliar

1. Palpação da massa muscular	2. Movimentação passiva
Avalia a consistência e a sensibilidade da massa muscular por pressão digital e deslocamento lateral do músculo.	Movimentos passivos em diferentes direções; analisa a resistência e a elasticidade dos músculos pela amplitude máxima dos movimentos articulares.

- ☐ Paciente em decúbito dorsal e relaxado.
- ☐ Não utilizar recursos que inibam o padrão espástico.
- ☐ Não tocar em locais que possam aumentar o tônus.
- ☐ Realizar a movimentação passiva em sentido oposto ao padrão espástico.

11.2 Resultado por segmento

Segmento	Tônus	Observações
Membro superior direito	☐ Normotônico ☐ Hipotônico ☐ Hipertônico	
Membro superior esquerdo	☐ Normotônico ☐ Hipotônico ☐ Hipertônico	
Membro inferior direito	☐ Normotônico ☐ Hipotônico ☐ Hipertônico	
Membro inferior esquerdo	☐ Normotônico ☐ Hipotônico ☐ Hipertônico	
Tronco	☐ Normotônico ☐ Hipotônico ☐ Hipertônico	

	HIPOTONIA	HIPERTONIA
Definição	Tônus reduzido mesmo em repouso (flacidez).	Tônus aumentado mesmo em repouso (espástico).
Lesão	Neurônio motor inferior (SNP lesado).	Neurônio motor superior (SNC lesado).
Tipo de paralisia	Paralisias flácidas.	Paralisias espásticas.

11.3 Tipo de hipertonia

ELÁSTICA (espasticidade)	PLÁSTICA (rigidez)
☐ Presente	☐ Presente
Resistência por contrações involuntárias; pode aumentar com o movimento e aumenta com a velocidade.	Resistência ao movimento, endurecimento muscular; diminui a velocidade e a amplitude dos movimentos.
Sinal do canivete.	Sinal da roda denteada; rigidez constante em toda a ADM.
Lesões piramidais (sistema que executa os movimentos — trato corticoespinhal), como o AVE.	Síndromes extrapiramidais (sistema que modula e regula os movimentos — núcleos da base), como o Parkinson.

11.4 Escala de Ashworth Modificada (grau de espasticidade)

Grau	Observação clínica
0	Tônus normal.
1	Aumento do tônus no início ou no final do arco de movimento.
1+	Aumento do tônus em menos da metade do arco de movimento, manifestado por tensão abrupta e seguido por resistência mínima.
2	Aumento do tônus em mais da metade do arco de movimento.
3	Partes em flexão ou extensão e movidas com dificuldade.
4	Partes rígidas em flexão ou extensão.

Registro: quais músculos são espásticos e qual o grau?

Músculo / grupo muscular	Lado	Grau (0, 1, 1+, 2, 3, 4)
	☐ D ☐ E	
	☐ D ☐ E	
	☐ D ☐ E	
	☐ D ☐ E	
	☐ D ☐ E	
	☐ D ☐ E	

12. EXAME DA COORDENAÇÃO

Conceitos (aula de Coordenação e Equilíbrio)

- Investigação do controle dos segmentos e da postura, de forma estática e dinâmica, em relação à metria e ao espaço.
- Coordenação motora: organização do movimento para um determinado fim.
- Depende do sistema motor (força, tônus, reflexos de postura), da sensibilidade proprioceptiva (posição dos segmentos e movimentos do corpo), do sistema vestibular (equilíbrio estático e dinâmico) e do sistema visual (percepção das relações espaciais).
- **Coordenação grossa:** envolve grandes grupos musculares. **Coordenação fina:** pequenos grupos musculares; avalia destreza e habilidade de manipulação.

12.1 Provas de coordenação

Prova	Execução	Direito	Esquerdo	Observações
MEMBROS SUPERIORES				
Índex-índex MMSS	Em pé ou sentado, olhos fechados, ombros em abdução de 90°: tocar as pontas dos dois indicadores, realizando adução horizontal.	☐ Normal ☐ Alterada	☐ Normal ☐ Alterada	
Índex-nariz MMSS	Em pé ou sentado, olhos fechados: tocar a ponta do indicador no nariz, alternadamente à direita e à esquerda.	☐ Normal ☐ Alterada	☐ Normal ☐ Alterada	
Índex-nariz-índex MMSS	Em pé: tocar o próprio nariz (olhos fechados) e depois o indicador do terapeuta (olhos abertos), alternadamente; o terapeuta muda a posição do dedo no espaço.	☐ Normal ☐ Alterada	☐ Normal ☐ Alterada	
Oponência MMSS – coordenação fina	Tocar a ponta do polegar na ponta de cada um dos outros dedos, sequencialmente.	☐ Normal ☐ Alterada	☐ Normal ☐ Alterada	
Movimentos alternados rápidos MMSS – diadococinesia	Realizar movimentos rápidos, repetidos e alternados (ex.: pronação e supinação), com os dois membros simultaneamente.	☐ Normal ☐ Alterada	☐ Normal ☐ Alterada	
MEMBROS INFERIORES				
Calcanhar-joelho MMII – bilateral	Em decúbito dorsal, elevar um MI e colocar o calcanhar sobre o joelho contralateral, deslizando pela tíbia até o hálux.	☐ Normal ☐ Alterada	☐ Normal ☐ Alterada	

12.2 Resposta do exame da coordenação

	Resposta	Definição
☐	**Diadococinesia**	Coordenação normal: executa movimentos rápidos, repetidos e alternados, com simetria, com membros opostos, simultaneamente.
☐	**Disdiadococinesia**	Realiza a atividade com alteração da coordenação: faz os movimentos alternados, porém com dificuldade.
☐	**Adiadococinesia**	Não realiza a atividade por ausência de coordenação: apresenta potencial motor, mas não realiza os movimentos.

Observações:

13. PROPRIOCEPÇÃO E EQUILÍBRIO

13.1 Exame da propriocepção

Conceitos

- Propriocepção: capacidade do corpo de perceber a posição e o movimento no espaço, independente da visão. É a sensibilidade profunda.
- Receptores: fuso muscular (comprimento, alongamento); órgão tendinoso de Golgi (tensão, força); receptores articulares (movimentos, posição articular); receptores cutâneos (contato, pressão).

Teste	Execução	Resultado	Tempo (s)
Teste de Romberg menor dificuldade	Pés juntos; olhos abertos → fechados. Observar se há oscilações durante 30 segundos.	☐ Negativo (sem oscilações) ☐ Positivo (com oscilações / queda)	
Romberg sensibilizado maior dificuldade	Posição tandem (um pé à frente do outro); olhos abertos → fechados. Observar oscilações durante 30 segundos.	☐ Negativo (sem oscilações) ☐ Positivo (com oscilações / queda)	

13.2 Exame do equilíbrio

Conceitos

- Equilíbrio é a resposta da postura e dos segmentos (membros).
- **Estático:** mantido por controle tônico-postural (postura fixa). **Dinâmico:** associação dos movimentos do tronco com os membros.

Equilíbrio estático

Teste	Execução	Resposta	Obs. / tempo
Posição de gato	Paciente em quatro apoios; deslocar o quadril e verificar se há resposta motora estática.	☐ Preservado ☐ Alterado	
Equilíbrio de tronco	Sentado; deslocar o tronco para fora do eixo de equilíbrio e observar a resposta motora de retorno ao eixo.	☐ Preservado ☐ Alterado	
Apoio unipodal – D	Em ortostatismo sobre o pé direito; observar oscilações.	☐ Preservado ☐ Alterado	_____ s
Apoio unipodal – E	Em ortostatismo sobre o pé esquerdo; observar oscilações.	☐ Preservado ☐ Alterado	_____ s

Equilíbrio dinâmico — marcha

Bom equilíbrio na marcha: ☐ Sim ☐ Não

Dissociação de cinturas: ☐ Presente ☐ Diminuída ☐ Ausente

Base de sustentação: ☐ Normal ☐ Alargada

Marcha com obstáculos (cones): ☐ Realiza ☐ Realiza com dificuldade ☐ Não realiza

Dispositivo auxiliar: ☐ Não ☐ Sim Qual: _____

Descrição da marcha:

Resposta ao exame do equilíbrio

☐ Equilíbrio preservado ☐ Déficit de equilíbrio ☐ Equilíbrio alterado

13.3 Escalas de equilíbrio aplicadas

Instrumentos padronizados e validados para medir, quantificar e avaliar a capacidade de manter a postura e a estabilidade corporal. Servem para identificar riscos, descobrir a causa do desequilíbrio, definir metas e acompanhar a evolução.

	Escala	Pontuação / tempo	Interpretação
☐	**Escala de Equilíbrio de Berg**	_____ / 56	
☐	**Mini-BESTest**	_____ / 28	
☐	**Timed Up and Go (TUG)**	_____ segundos	
☐	**Escala de Equilíbrio Pediátrica**	_____ / 56	

14. EXAME DA SENSIBILIDADE

Conceitos (aula de Exame da Sensibilidade)

- A avaliação da sensibilidade superficial deve se basear nos dermátomos: territórios da pele inervados por fibras sensitivas de um mesmo segmento medular.
- **Superficial:** estímulos do ambiente externo (dor, temperatura e tato), captados pelos receptores da pele.
- **Profunda (proprioceptiva):** posição do corpo no espaço, movimentos e vibração, captados pelos receptores dos músculos, articulações e tendões.
- Paciente de olhos fechados; demonstrar antes o estímulo em uma área normal; percorrer os dermátomos no sentido crânio-caudal, comparando os dois lados.

Sigla	Resposta	Significado
N	**Normoestesia**	Normal; não apresenta alteração de sensibilidade.
Hipo	**Hipoestesia**	Diminuição da sensibilidade (na dor: hipoalgesia).
Hiper	**Hiperestesia**	Aumento anormal da sensibilidade (dolorosa).
A	**Anestesia**	Ausência da sensibilidade (na dor: analgesia).

14.1 Sensibilidade superficial

Modalidade	Material	Técnica
Tátil	Mecha de algodão ou pincel do martelo de reflexos.	Diferenciar áreas de percepção normal das hipoestésicas ou anestésicas.
Dolorosa	Objeto pontiagudo (agulha descartável).	Mostrar o objeto e testar em área normal; percutir sobre os dermátomos no sentido crânio-caudal. O paciente deve distinguir o tato da dor e delimitar áreas normais, hipoalgésicas ou analgésicas.
Térmica	Dedo do examinador (quente) e cabo metálico do martelo (frio).	O paciente reconhece qual objeto toca a pele. Evitar temperaturas extremas, pois o paciente pode perceber dor e não a diferença de temperatura.

Registro por dermátomo (use N, Hipo, Hiper ou A)

Derm.	Ponto de referência	Tátil		Dolorosa		Térmica	
		D	E	D	E	D	E
C4	Topo do ombro (articulação acromioclavicular)						
C5	Face lateral do cotovelo						
C6	Polegar						
C7	Dedo médio						
C8	Dedo mínimo						

Derm.	Ponto de referência	Tátil		Dolorosa		Térmica	
		D	E	D	E	D	E
T1	Face medial do cotovelo						
T4	Linha dos mamilos						
T6	Processo xifoide						
T10	Cicatriz umbilical						
T12	Ponto médio do ligamento inguinal						
L1	Região inguinal (entre T12 e L2)						
L2	Face anterior e medial da coxa (terço médio)						
L3	Côndilo femoral medial (joelho)						
L4	Maléolo medial						
L5	Dorso do pé (3ª articulação metatarsofalângica)						
S1	Face lateral do calcanhar						
S2	Fossa poplítea						

Pontos-chave dos dermátomos conforme o padrão internacional de exame neurológico (ASIA). Registre também áreas alteradas fora destes pontos.

Áreas com alteração: _____

14.2 Sensibilidade profunda

Modalidade	Técnica	Direito	Esquerdo
Cinestesia propriocepção consciente	Olhos fechados; movimentar o polegar (ou o hálux) em flexão e extensão de forma desordenada e perguntar a posição final do dedo e a direção do movimento.	☐ N ☐ Hipo ☐ Hiper ☐ A	☐ N ☐ Hipo ☐ Hiper ☐ A
Vibratória	Diapasão posicionado sobre região articular e periarticular (proeminências ósseas).	☐ N ☐ Hipo ☐ Hiper ☐ A	☐ N ☐ Hipo ☐ Hiper ☐ A
Dolorosa à compressão profunda	Compressão manual vigorosa de massas musculares ou do tendão do calcâneo.	☐ N ☐ Hipo ☐ Hiper ☐ A	☐ N ☐ Hipo ☐ Hiper ☐ A
Grafestesia	Escrever letras ou números na palma da mão com um objeto; o paciente deve identificá-los.	☐ N ☐ Hipo ☐ Hiper ☐ A	☐ N ☐ Hipo ☐ Hiper ☐ A
Estereognosia	Colocar objetos familiares em cada mão (olhos fechados); o paciente deve identificá-los pela palpação/preensão.	☐ N ☐ Hipo ☐ Hiper ☐ A	☐ N ☐ Hipo ☐ Hiper ☐ A

Discriminação de dois pontos (tato epicrítico)

Pesquisada com compasso ou dois objetos: é a distância mínima abaixo da qual dois estímulos simultâneos deixam de ser percebidos como distintos.

Região	Valor de referência	Direito (mm)	Esquerdo (mm)
Língua	1 mm		
Lábios	2 a 3 mm		
Dedo da mão (polpa)	2 a 3 mm		
Dedo do pé	3 a 8 mm		
Palma da mão	8 a 15 mm		

Conclusão do exame da sensibilidade:

15. EXAME FÍSICO ESPECÍFICO E SÍNTESE DOS ACHADOS

15.1 Testes, manobras e sinais específicos

Espaço para testes especiais complementares, de acordo com a queixa e o diagnóstico do paciente.

Teste / manobra / sinal	Lado	Resultado	Interpretação
	☐ D ☐ E	☐ Positivo ☐ Negativo	
	☐ D ☐ E	☐ Positivo ☐ Negativo	
	☐ D ☐ E	☐ Positivo ☐ Negativo	
	☐ D ☐ E	☐ Positivo ☐ Negativo	
	☐ D ☐ E	☐ Positivo ☐ Negativo	
	☐ D ☐ E	☐ Positivo ☐ Negativo	

15.2 Síntese dos achados da avaliação

Reúna aqui as principais alterações encontradas e as capacidades preservadas — esta síntese fundamenta o diagnóstico fisioterapêutico.

Alterações / problemas encontrados	Capacidades e funções preservadas

16. DIAGNÓSTICO, PROGNÓSTICO, OBJETIVOS E CONDUTAS

Diagnóstico fisioterapêutico	Objetivos	Condutas (plano terapêutico)	Evolução diária
Elaborado ao final da avaliação	Definidos a partir do diagnóstico	Definem o plano terapêutico	Registro de cada atendimento

16.1 Diagnóstico cinético-funcional (fisioterapêutico)

Descreve a disfunção do movimento e da função (não a doença). Ex.: DC = AVE à direita → diagnóstico fisioterapêutico = hemiplegia à esquerda.

16.2 Prognóstico

☐ Favorável ☐ Reservado ☐ Desfavorável

16.3 Objetivos do tratamento

Prazo	Nº	Objetivo
Curto prazo	1.	
	2.	
	3.	
Médio prazo	1.	
	2.	
	3.	
Longo prazo	1.	
	2.	
	3.	

16.4 Planejamento terapêutico — condutas

Objetivo relacionado	Conduta / recurso terapêutico	Parâmetros (séries, repetições, tempo, carga)

Frequência: _____ vezes por semana **Duração da sessão:** _____ min

Reavaliar em: _____

16.5 Orientações domiciliares

17. EVOLUÇÃO DE ATENDIMENTO DIÁRIO

O que a evolução deve conter

- Como o paciente chegou (queixas iniciais) → sinais vitais iniciais → condutas realizadas no atendimento do dia → sinais vitais finais → informações finais.

Atendimento nº 1	Data: ____/____/_____ Horário: _____
Como o paciente chegou (queixas iniciais)	
Sinais vitais iniciais	PA: _____/_____ mmHg FC: _____ bpm FR: _____ rpm T: _____ °C
Condutas realizadas	
Sinais vitais finais	PA: _____/_____ mmHg FC: _____ bpm FR: _____ rpm T: _____ °C
Informações finais / intercorrências	
Assinaturas	Acadêmico(a): _____ Supervisor(a): _____

Atendimento nº 2	Data: ____/____/_____ Horário: _____
Como o paciente chegou (queixas iniciais)	
Sinais vitais iniciais	PA: _____/_____ mmHg FC: _____ bpm FR: _____ rpm T: _____ °C
Condutas realizadas	
Sinais vitais finais	PA: _____/_____ mmHg FC: _____ bpm FR: _____ rpm T: _____ °C
Informações finais / intercorrências	
Assinaturas	Acadêmico(a): _____ Supervisor(a): _____

Atendimento nº 3	Data: ____/____/_____ Horário: _____
Como o paciente chegou (queixas iniciais)	
Sinais vitais iniciais	PA: _____/_____ mmHg FC: _____ bpm FR: _____ rpm T: _____ °C
Condutas realizadas	
Sinais vitais finais	PA: _____/_____ mmHg FC: _____ bpm FR: _____ rpm T: _____ °C
Informações finais / intercorrências	
Assinaturas	Acadêmico(a): _____ Supervisor(a): _____

Atendimento nº 4	Data: ____/____/_____ Horário: _____
Como o paciente chegou (queixas iniciais)	
Sinais vitais iniciais	PA: _____/_____ mmHg FC: _____ bpm FR: _____ rpm T: _____ °C
Condutas realizadas	
Sinais vitais finais	PA: _____/_____ mmHg FC: _____ bpm FR: _____ rpm T: _____ °C
Informações finais / intercorrências	
Assinaturas	Acadêmico(a): _____ Supervisor(a): _____

18. REAVALIAÇÃO E ALTA FISIOTERAPÊUTICA

18.1 Reavaliação

Data da reavaliação: _____ **Nº de sessões realizadas:** _____

Parâmetro	Avaliação inicial	Reavaliação	Evolução
Pressão arterial (mmHg)			☐ Melhorou ☐ Igual ☐ Piorou
Frequência cardíaca (bpm)			☐ Melhorou ☐ Igual ☐ Piorou
Frequência respiratória (rpm)			☐ Melhorou ☐ Igual ☐ Piorou
Temperatura (°C)			☐ Melhorou ☐ Igual ☐ Piorou
Dor (0 a 10)			☐ Melhorou ☐ Igual ☐ Piorou
Perimetria (cm)			☐ Melhorou ☐ Igual ☐ Piorou
Força muscular (grau)			☐ Melhorou ☐ Igual ☐ Piorou
Tônus (Ashworth)			☐ Melhorou ☐ Igual ☐ Piorou
Coordenação			☐ Melhorou ☐ Igual ☐ Piorou
Equilíbrio (escala / teste)			☐ Melhorou ☐ Igual ☐ Piorou
Sensibilidade			☐ Melhorou ☐ Igual ☐ Piorou
Postura			☐ Melhorou ☐ Igual ☐ Piorou
Funcionalidade (AVD)			☐ Melhorou ☐ Igual ☐ Piorou

Conduta após a reavaliação:

_____

_____

_____

18.2 Alta fisioterapêutica

Data da alta: _____ **Total de sessões:** _____

Motivo da alta:

☐ Objetivos alcançados ☐ Encaminhamento a outro serviço ☐ A pedido do paciente

☐ Abandono do tratamento ☐ Outro: _____

Orientações de alta:

_____

_____

18.3 Declaração e assinaturas

Declaro que as informações contidas nesta ficha de avaliação são verdadeiras e foram colhidas com o consentimento do paciente / responsável.

Local e data: _____, ____ / ____ / _____

_____	_____
Paciente / responsável	**Acadêmico(a) avaliador(a)**
Nome legível	Nome e RA

_____

Fisioterapeuta supervisor(a)
Nome e CREFITO

ANEXO — SIGLAS E ABREVIATURAS

Sigla	Significado	Sigla	Significado
ADM	Amplitude de movimento	**AHTX**	Ambos os hemitórax
AP	Ausculta pulmonar	**AVD**	Atividades de vida diária
AVE	Acidente vascular encefálico	**AVP**	Atividades de vida prática / profissional
A-V	Atrioventricular (valvas mitral e tricúspide)	**B1 / B2**	Primeira / segunda bulha cardíaca
bpm	Batimentos por minuto	**BRNF 2T SS**	Bulhas rítmicas normofonéticas, 2 tempos, sem sopros
D / E	Direito / esquerdo	**DC**	Diagnóstico clínico / débito cardíaco
DD / DV	Decúbito dorsal / decúbito ventral	**EC**	Estertores crepitantes
EIAS	Espinha ilíaca anterossuperior	**EIC**	Espaço intercostal
FC	Frequência cardíaca	**FR**	Frequência respiratória
HA	Hipertensão arterial	**HDA / HMA**	História da doença / moléstia atual
HDP / HMP	História da doença / moléstia pregressa	**HF**	Histórico familiar
HS	Histórico social	**IMC**	Índice de massa corporal
ipm / rpm	Incursões / respirações por minuto	**MAPA / MRPA**	Monitorização ambulatorial / residencial da PA
MMSS / MMII	Membros superiores / membros inferiores	**MSD / MSE**	Membro superior direito / esquerdo
MID / MIE	Membro inferior direito / esquerdo	**MV**	Murmúrio vesicular
PA	Pressão arterial	**PAM**	Pressão arterial média
PAS / PAD	Pressão arterial sistólica / diastólica	**QP**	Queixa principal
RA	Ruídos adventícios	**RVP**	Resistência vascular periférica
SIC	Segundo informações colhidas	**SNC / SNP**	Sistema nervoso central / periférico
T°	Temperatura corporal	**TEC**	Tempo de enchimento capilar
TUG	Timed Up and Go	**VD / VE**	Ventrículo direito / esquerdo

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, A. A. et al. Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial – 2025. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 122, n. 9, e20250624, 2025. DOI: 10.36660/abc.20250624.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de atenção integrada às doenças prevalentes da infância**. Brasília: Ministério da Saúde, 2003.

AMERICAN HEART ASSOCIATION. **Pediatric Advanced Life Support (PALS)**. Dallas: American Heart Association.

CABRINI, M. L. **Bases e Métodos de Avaliação I**: processo de avaliação; sinais vitais (temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial); ausculta pulmonar; ausculta cardíaca; avaliação postural; avaliação vascular. Material de aula. Curso de Fisioterapia, 2º termo.

NUNES, N. **Bases e Métodos de Avaliação I**: avaliação vascular; trofismo, perimetria e manobras deficitárias; exame motor – tônus muscular; exame da coordenação e equilíbrio; exame da sensibilidade. Material de aula. Curso de Fisioterapia, 2º termo.